

證據基礎與未來方向

對應原書：Greenberg, L. S., & Tomescu, L. R. (2017). *Supervision Essentials for Emotion-Focused Therapy*. APA. 第6章 Research (pp. 141–145) + 第7章 Future Directions (pp. 147–149) + 推薦書目 (pp. 151–152) 本檔內容：學習目標 | 完整學術摘要 | 核心概念洞見 | 關鍵原文引述 | 臨床推理框架

標示說明：「原教材指出」表示內容直接來自原書；「從臨床實務角度」表示本教材的延伸詮釋。原書對所引研究多半只摘述結論，未提供樣本、設計與效果量；本教材在「證據性質」欄中如實標示，不補充原書未提供的研究細節。

本單元學習目標

完成本單元後，你能夠：

1. 能區分本模式各項主張的證據類型（直接的 EFT 督導研究、一般督導研究、EFT 治療結果與歷程研究、訓練研究、作者主張），並評估每類證據的強度。〔評鑑／反思實務〕
2. 能說明共同因素與特定因素如何共同構成 EFT 督導，並把本模式定位於 Watkins 等人的跨理論框架中。〔理解／治療關係〕
3. 能依四種經驗性治療訓練方法，為自己設計一份結合錄影回饋的一學期技能學習計畫。〔創造／反思實務〕
4. 能提出一個可檢驗的研究問題，針對「受督者學習歷程」這個最少被研究的環節，並說明研究設計與限制。〔創造／反思實務〕
5. 能評論「錄影回饋優於講解、反思或示範」這個主張的證據基礎，並指出在台灣實習場域使用錄影時的倫理與知情同意考量。〔評鑑／倫理〕

§2 完整學術摘要

A. 主題與背景

前五章說明了 EFT 督導是什麼、怎麼做。第6章回答：這個模式有什麼證據支持？第7章回答：接下來需要發展與研究什麼？

為什麼對碩士生重要（從臨床實務角度）：本單元是全書的批判性評估單元。學會區分「有研究支持」「有相關研究支持其成分」「作者的臨床主張」，是證據本位實務的核心能力，也決定了我們在實務中應該以多大的信心採用這個模式。

B. 第6章：研究

B1. 支持本模式的兩條研究路線

原教材指出，本模式受到兩條研究路線支持，主要來自 EFT 的實證研究：

1. 關係的重要性；
2. 特定的改變歷程。

原教材也坦白說明：直接研究 EFT 督導本身的研究只有少量；有一些關於訓練的研究；與督導相關的一般心理治療研究則多得多。

B2. 直接研究 EFT 督導：Palmer-Olsen (2007)

項目	原教材的描述
方法	以現象學哲學為基礎的系統性結構化研究取向；透過訪談、討論與參與觀察蒐集深入資訊
對象	伴侶 EFT 治療師對 EFT 訓練與督導的經驗；質性研究，17 位參與者
背景	伴侶 EFT 最初由 Greenberg 與 Johnson (1988) 發展，包含系統性成分，後來發展為依附本位的伴侶治療 (Johnson, 2004)。原教材認為，伴侶 EFT 基本上與本書聚焦的個人 EFT 建立在相同的情緒原則上

六項發現：好的 EFT 督導與訓練——

#	發現
(a)	需要強的督導同盟
(b)	督導者納入「治療師自我」(self of the therapist) 的議題時，效果最好
(c)	參與者需要能取得 EFT 的書面資料
(d)	需要示範與練習 EFT 的概念與介入
(e)	需要透過現場晤談與錄影或錄音檢視，觀察臨床工作
(f)	包含目標設定，以及督導者與受督者之間非正式與評量性的元素

證據評估（從臨床實務角度）：

- 這是本書中唯一直接研究 EFT 督導的實證研究，屬於質性、小樣本研究，適合產生假設，不適合推論效果。
- 研究對象是伴侶 EFT，推論到個人 EFT 督導，需要接受作者「情緒原則相同」的前提。
- 原書未說明研究是否經過同儕審查（例如是否為學位論文），也未說明分析方法細節。

B3. 與 EFT 相關的督導研究

① Ladany、Friedlander 與 Nelson 的事件本位模式 (2005, 2016)

- 依據豐富的督導經驗，以任務分析取向分析督導逐字稿，提出事件本位的督導模式。這與 EFT 的事件本位、任務分析督導模式相關 (Greenberg, 1984)。
- 他們顯示，常被忽略的督導困境都是可以被辨識、共同探索並克服的督導事件：

常被忽略的督導事件
角色的模糊
與文化背景和性別有關的誤解
問題性的態度與行為
技能不足
反移情
對個案的性吸引

- 這個模式顯示受督者的問題可以轉化為成長的機會，而有效解決督導者與受督者之間的困難，能示範處理與個案互動的正向方式 (參照 Bertsch et al., 2014)。

② Watkins、Budge 與 Callahan (2015) 的督導模式

- 以 Wampold 與 Budge (2012) 的心理治療關係模式為基礎，提出共同因素與特定因素的匯合。
- 內容包括：同盟連結的初始建立與持續維護，以及隨後的一系列改變。這些改變來自：
- 與受督者的真實關係；
- 督導者設定督導歷程的框架與期待；
- 督導者投入建立任務與目標的共識；
- 受督者參與某種形式的教育性行動：嘗試並精煉行動。
- 他們認為，這些會帶來受督者焦慮、羞愧與自我懷疑的降低，以及治療師認同與治療技能的發展。
- EFT 的定位：原教材指出，EFT 督導模式可以放進這個跨理論框架；而讓督導成為特定的情緒焦點督導的，是特定的任務與治療行動，以及一貫的情緒焦點。

③ 支持模式成分的一般督導研究

原教材指出，雖然直接針對 EFT 督導模式的研究不多，但有研究支持模式的成分：

研究	原教材摘述的發現	支持模式的哪個成分
Neufeldt, Beutler, & Banchemo (1997)	督導者在督導中展現 Rogers 核心條件（同理、真誠、正向關懷），可能提升受督者對個案的行為	督導者的同理與真誠
督導工作同盟研究；Ladany (2002)	好的同盟可在許多指標上預測好的督導；督導者創造好同盟的能力，一再被證實能預測督導中的好結果；強的督導工作同盟在督導歷程與結果中扮演重要角色	同盟是中心支柱

研究	原教材摘述的發現	支持模式的哪個成分
Falender & Shafranske (2004) 的研究摘要	督導關係中的信任與尊重、督導者對受督者發展需求的敏感、督導者鼓勵受督者自主，是好督導的重要元素	合作、尊重、依發展程度調整
Ladany & Walker (2003)	適當的督導者揭露，能藉由傳達對受督者的信任，強化督導同盟的情感連結	經驗性在場回應中的揭露

原教材的結論是：這些都屬於 EFT 督導中作為督導關係基礎的同理關係環境。

B4. EFT 訓練的相關研究

原教材指出，EFT 督導包含大量訓練。

① 四種訓練方法 (Greenberg & Goldman, 1988)

經驗性治療的訓練，在結合多種方法時最有效：

方法	說明
概念學習	理論與研究
行為技能訓練	包括示範與練習
經驗性學習	親身經驗情緒歷程
個人治療	處理自己的議題

訓練中的經驗性成分非常重要。

② Montagno、Svatovic 與 Levenson (2011)

- 參加伴侶 EFT 外訓 (externship) 之後，參與者的 EFT 知識與能力提升，對自己的感受更開放，更自我慈悲，也較少使用迴避型依附行為。
- 參與者大多是有執照的臨床工作者，也報告自己的關係，特別是與伴侶的關係，出現轉變。
- 作者認為，這些結果凸顯了 EFT 訓練所強調的經驗性成分的重要性。
- 證據評估（從臨床實務角度）：原書未說明研究設計（例如是否有對照組）與測量方式；關係上的轉變是參與者的自述。這類前後測研究無法排除其他解釋，例如期待效應與自我選擇。

③ 兩種不同的技能 (Ivey, 1971 ; Pagell, Carkhuff, & Berenson, 1967)

技能	學習方式
專注、摘要感受等技能	可以透過簡短的微諮商訓練等教學取向習得（參照 Ivey, 1971）
創造並維持同理關係的能力	是不同類型的技能，較多以經驗性的方式學習（Pagell et al., 1967）。它涉及聽見更細微的感受與複雜的意義，因此需要更多時間與個人發展才能習得

④ 完形技能的系統化訓練 (Greenberg & Kahn, 1976 ; Greenberg & Sarkissian, 1984)

- Greenberg 與 Kahn (1976) 認為，EFT 中涉及的某些完形治療技能可以系統地教授，並設計了一套結合教學、經驗與技能訓練的方案，使用上述四種訓練歷程。
- 方案的理由：對個人議題的覺察增加，會促進受督者的治療敏感度，以及對改變歷程的第一手認識；此外，由自我覺察增加而學習特定技能，被視為能促進更好的學習。
- Greenberg 與 Sarkissian (1984) 的研究顯示此方案在訓練學生使用雙椅技術上的有效性。訓練後，治療師：
 - 更常以適當的雙椅對話介入回應個案的衝突陳述；
 - 提供更多直接的引導；
 - 更直接地注意非語言的指涉。

原教材據此認為，這證明了此方案在訓練主動介入技能上的有效性。

B5. EFT 的治療結果與歷程研究

- EFT 已在多項隨機對照試驗中，被證明對個人與伴侶的憂鬱、複雜創傷與婚姻困擾有效 (Elliott, Greenberg, & Lietaer, 2004 ; Johnson, Hunsley, Greenberg, & Schindler, 1999) 。
- 除了臨床試驗，關於使用標記引導的任務，以及情緒在治療改變中的獨立角色的實證研究，一貫顯示晤談中的情緒活化與結果之間有關聯 (Greenberg, 2010) 。
- 許多文章、章節與書籍發表了與結果有關的 EFT 臨床歷程，為督導者提供可依循的藍圖。
- 這些發現支持督導者促進受督者使用標記引導的任務與情緒喚起。
- 對督導的意義：這些研究為督導者勾勒出一位勝任的 EFT 實務工作者需要知道什麼。然而，仍需要進一步研究如何最好地督導，以促進這些技能的習得。

B6. 第6章結論

原教材指出，心理治療文獻中的許多研究發現，支持本督導模式建議的活動。這些研究支持能讓督導者對所提出的督導歷程更有信心：

- 與受督者發展良好關係，並督導他們與個案建立良好關係，看起來受到一般督導研究支持；
- 促進個案的情緒深化，並投入特定的標記引導介入，則是實證本位的歷程，督導者可以有信心地在 EFT 督導中教授。

C. 第7章：未來方向

C1. 本模式的本質：共同因素加特定因素

- 原教材指出，EFT 督導依賴共同因素與特定因素的結合。關係構成督導可信賴的核心，但透過督導特定的技術面向而大為增強。
- 作者提出的是一個分析性、以任務為本的督導模式，聚焦於督導者與受督者、治療師與個案之間的關係，以及技術因素。
- EFT 的兩大焦點是：(a) 同理的關係方式，以及 (b) 情緒。

- 督導與治療平行，聚焦於這兩大成分：促進受督者作為一個人的成長與發展，以及協助受督者發展治療師的認同與技能。

C2. 科技

- 督導在 21 世紀會因科技而有各種發展：先進的視聽輔助、虛擬實境模擬器、即時通訊、行動應用程式。
- Carl Rogers 在 1940 年代首先錄下治療晤談，這改變了心理治療研究的方向，開啟了治療接受檢視的歷程。
- 治療晤談的影像與數位錄影，現在就像心理治療的顯微鏡，對心理治療督導具有極大價值。作者幾乎無法想像不用實際晤談錄影來做 EFT 督導。
- 原教材主張：觀看錄影並取得督導回饋，比講授、反思或示範更能促進技能學習。所有訓練方案，尤其是 EFT 訓練，都會把錄影納入作為督導與訓練的必要條件。
- 本章其餘部分聚焦於非科技的改變。

證據評估（從臨床實務角度）：「錄影回饋比講授、反思或示範更能促進技能學習」是本章中一個比較性的因果主張，但原書在此沒有附上任何引用。第6章引用的 Greenberg 與 Sarkissian（1984）支持的是結合多種方法的訓練方案，而不是錄影單獨優於其他方法。因此這應視為作者依據經驗提出的主張，需要研究檢驗。

C3. 五個重要的發展領域

原教材列出：

1. 督導關係；
2. 具體化：更清楚地界定督導的成分與能力；
3. 個人化：配合受督者調整；
4. 考慮個別差異；
5. 處理情緒的能力。

關於關係：

- 關係概念很可能會繼續發展，並成為督導的基石。
- 督導者與受督者之間安全、可信任的關係連結的價值已一再被肯定；這一點，以及有共識的目標與任務的重要性，將引導督導。
- 同理與督導同盟將被牢固地確立為心理治療督導中的共同因素。
- 未來研究的關鍵問題：受督者需要與督導者一起投入哪些認知、情緒與行為歷程，才能學會成為更好的治療師？

C4. 最少被研究的一環：受督者的學習歷程

- 本書描述的是第一個以任務分析取向發展的 EFT 督導模式，作者希望它被進一步發展與實證研究。
- 特別重要的是研究並界定受督者的學習歷程。它目前仍是「標記—任務環境—歷程—解決」這個序列中最少被研究、最不清楚的部分。
- EFT 督導會走向能力本位、實證本位，也更可問責。

- 下一個重要步驟，是進一步界定能清楚反映 EFT 獨特治療與督導風格的督導能力。特別關鍵的是：
- 如何促進受督者處理情緒的工作；
- 如何協助他們克服對處理情緒的恐懼；
- 也非常需要更成熟的方法來教授對情感的同理調頻。
- 若督導實務與督導訓練要發展並成功，這些與其他能力需要進一步清楚說明。

C5. 個別差異與情境

- 釐清督導歷程需要如何調整，以處理不同情境中的個別差異與需要，會成為更高的優先事項。
- 例如，對同理天分沒那麼高，或情緒能力較弱的受督者，如何調整督導，還需要更多工作。
- 我們需要更了解如何在受督者目前所在之處與他相遇，而不是期待他能直接跳到我們希望他在的地方。
- 這暗示一個階段式的督導模式：了解應該從哪裡開始（可能是簡單的同理訓練），以及何時、如何推進，直到建立起受督者投入 EFT 複雜情緒焦點介入的技能。
- 此外，督導研究生與博士後學生，與督導職場中的專業人員，兩者的差異需要被界定。

C6. 研究方法

- 量化與質性研究在 EFT 督導的未來中，將占有越來越重要的位置。
- EFT 是藉由研究治療的逐刻歷程發展出來的；同樣地，我們也需要研究督導的逐刻歷程。本書提出的任務分析框架，就是協助這類研究的方法。
- 作者希望本書是發展更有科學依據的督導實務證據基礎的第一步。

C7. 推薦書目（原書 pp. 151–152）

書目	原書的推薦理由（摘述）
Elliott, Watson, Goldman, & Greenberg (2004) . <i>Learning Emotion-Focused Therapy</i>	EFT 概覽與不同介入的技能；適合想學介入微技巧者
Goldman & Greenberg (2015) . <i>Case Formulation in Emotion-Focused Therapy</i>	可能是概念化 EFT 治療師如何進行治療最完整的書
Greenberg (2010) . Emotion-focused therapy: A clinical synthesis. <i>Focus</i> , 8(1)	EFT 的摘要概覽
Greenberg (2011) . <i>Emotion-Focused Therapy</i>	EFT 理論與實務最精簡的陳述；適合入門
Greenberg (2015) . <i>Emotion-Focused Therapy: Coaching Clients to Work Through Their Feelings</i> (2nd ed.)	在治療與生活中處理情緒的整體取向；包含發展情緒能力的練習
Greenberg & Watson (2006) . <i>Emotion-Focused Therapy for Depression</i>	以憂鬱為脈絡，說明 EFT 從頭到尾如何進行的最完整文本

D. 理論架構：證據的層級地圖

以下是本教材整理的證據地圖，對應全書各主張：

證據類型	原書引用的例子	能支持什麼	不能支持什麼
① 直接的 EFT 督導研究	Palmer-Olsen (2007) , 質性, n = 17 , 伴侶 EFT	督導與訓練中被經驗為有幫助的元素	督導的效果；個人 EFT 的類推
② 一般督導研究	Ladany (2002) ; Neufeldt 等 (1997) ; Ladany & Walker (2003) ; Falender & Shafranske (2004)	同盟、核心條件、揭露等關係成分的價值	EFT 特定督導技術的效果
③ 督導模式與理論	Ladany 等 (2005, 2016) ; Watkins 等 (2015)	事件本位與共同／特定因素的理論定位	效果本身
④ EFT 訓練研究	Greenberg & Goldman (1988) ; Greenberg & Sarkissian (1984) ; Montagno 等 (2011)	結合教學、經驗與技能訓練的方案能改變受訓者行為	督導（而非訓練）的效果；長期效果
⑤ EFT 治療結果與歷程研究	Elliott 等 (2004) ; Johnson 等 (1999) ; Greenberg (2010)	要教什麼：標記引導任務、情緒活化	怎麼督導最有效
⑥ 作者的臨床經驗與主張	錄影回饋優於其他方法；多元文化督導無根本差異；先憤怒後悲傷	臨床假設	需要研究檢驗

核心結論（從臨床實務角度）：EFT 督導的內容（要教什麼）有相對較好的證據支持；EFT 督導的方法（怎麼教最好）主要依賴一般督導研究、訓練研究與作者經驗。直接檢驗 EFT 督導效果的研究仍然缺乏，作者也坦承這一點。

E. 實證基礎的強度與限制（整體評估）

面向	評估
研究數量	直接研究 EFT 督導的只有 1 篇質性研究
研究設計	原書多半只摘述結論，未提供樣本、設計與效果量；無法由原書判斷各研究的品質
類推性	多項研究以伴侶 EFT 為對象；一般督導研究不一定適用於 EFT 特有的技術督導
因果推論	「晤談中情緒活化與結果有關聯」屬於相關；「錄影回饋優於其他方法」未附引用
作者的誠實	作者明確承認受督者學習歷程最不清楚，並呼籲以逐刻歷程研究督導

F. 臨床意義

面向	本單元的意涵
採用模式的信心	對關係成分與要教的內容，可以有較高的信心；對特定督導技術的效果，應保持開放與謹慎
自我學習計畫	結合四種訓練方法：概念學習、行為技能訓練（示範與練習）、經驗性學習、個人治療
同理的學習	基本技能可以靠教學習得；同理關係需要時間、經驗與個人發展
錄影	錄影是 EFT 督導的核心工具，但使用時要有知情同意與保密規範
階段式學習	從簡單的同理訓練開始，逐步走向複雜的情緒焦點介入
研究素養	能區分證據類型，是證據本位實務的核心能力

G. 臨床推理：如何評估一個督導主張？

以「錄影回饋比講授、反思或示範更能促進技能學習」為例：

1. 這個主張屬於哪一類證據？作者的主張，原書在此沒有附引用。
2. 有沒有相關研究間接支持？第6章的 Greenberg 與 Sarkissian (1984) 支持結合多種方法的訓練方案；Palmer-Olsen (2007) 發現觀察臨床工作（包括錄影）是好督導的元素之一。
3. 這些研究能支持「優於」嗎？不能。它們沒有比較錄影與其他方法的效果。
4. 替代解釋：錄影的價值可能來自它讓督導者看到實際歷程，而不是錄影本身；結合錄影與示範、練習，可能才是有效成分。
5. 還需要什麼研究？隨機分派受訓者到不同訓練條件，以晤談中的技能表現（例如以量表編碼）作為結果。
6. 對實務的決策：使用錄影，因為它有良好的理論理由與間接支持；但同時結合示範與練習，並持續評估受督者的學習。

H. 常見誤解與臨床陷阱

1. 把「EFT 是實證治療」等同於「EFT 督導已被實證」。
2. 把相關性研究當作因果證據，例如情緒活化與結果的關聯。
3. 把伴侶 EFT 的研究直接類推到個人 EFT 督導，而不說明前提。
4. 把作者的臨床主張當作研究結論，例如錄影優於其他方法。
5. 以為同理可以只靠講授學會。
6. 把個人治療視為可有可無；原書把它列為訓練的四種方法之一。
7. 期待一次就學會複雜介入，而不是階段式地建立技能。
8. 忽略受督者學習歷程仍是未知。督導成效需要持續評估。
9. 使用錄影時忽略知情同意與保密。

I. 倫理、文化與專業考量

- 錄影的倫理（從臨床實務角度）：在台灣的實習場域，錄影需要個案書面知情同意，說明用途（督導與教學）、觀看者、保存方式與期限、銷毀方式，以及個案可隨時撤回同意；錄影檔案需加密保存，並遵守機構規範與個人資料保護相關法規。個案拒絕錄影時，不得影響其接受服務的權利。
- 個人治療的建議：原書把個人治療列為訓練方法之一。從臨床實務角度，督導者建議個人治療時要尊重受督者的自主，並避免讓它成為評量的一部分。
- 能力本位與可問責：走向能力本位的督導，意味著評量標準要清楚、公開，並與受督者溝通。
- 個別差異：階段式模式提醒督導者，不要以單一標準要求所有受督者，而要從受督者目前的程度開始。
- 文化（從臨床實務角度）：原書的研究多來自北美與歐洲；在台灣應用時，需要考慮文化對情緒表達、督導權力關係與錄影接受度的影響。這也是值得研究的方向。

J. 學習者必須帶走的核心知識

層次	內容
必須記住	兩條研究路線；Palmer-Olsen 的六項發現；Ladany 等人的六種常被忽略的督導事件；四種訓練方法；五個未來發展領域；受督者學習歷程是最少被研究的環節
應該理解	共同因素與特定因素的結合；要教的內容 vs. 怎麼教的證據差異；技能與同理關係的不同學習方式；階段式督導模式的構想
能夠應用	為一個督導主張判斷證據類型；設計結合四種方法的學習計畫；提出一個研究受督者學習歷程的研究問題
能夠批判性思考	直接證據的缺乏；類推的限制；未附引用的比較性主張；研究的文化來源

§3 核心概念洞見

洞見一：要教什麼，比怎麼教有更好的證據

- 核心命題：EFT 的治療結果與歷程研究，清楚指出勝任的 EFT 治療師需要會什麼（標記引導任務、情緒深化）；但「如何督導才能最有效地教會這些」，直接研究很少。
- 臨床重要性：這讓我們能分辨：哪些督導內容可以有信心地教，哪些督導方法仍需要保持開放。
- 對臨床推理的影響：面對督導建議時問：「這是關於要學什麼，還是關於怎麼學？它的證據是哪一種？」
- 例子：「要協助個案情緒深化」有歷程—結果研究支持；「用錄影回饋教這件事最有效」則是作者主張。
- 常見學生誤解：以為一個實證治療取向，它的督導方法也自動是實證的。

- 教學重點：區分內容的證據與方法的證據。

洞見二：EFT 督導 = 共同因素 + 情緒焦點的特定因素

- 核心命題：EFT 督導可以放進 Watkins 等人的跨理論框架：同盟、真實關係、框架與期待、任務與目標共識、教育性行動。讓它成為「EFT 督導」的，是特定的任務與治療行動，以及一貫的情緒焦點。
- 臨床重要性：這讓不同取向的督導者與受督者有共同語言，也凸顯 EFT 督導的獨特之處。
- 對臨床推理的影響：評估一次督導時，可以分別問：共同因素（關係、同盟）夠不夠好？特定因素（情緒焦點、標記與任務）有沒有被教到？
- 例子：一次溫暖但只談個案背景的督導，共同因素良好，卻缺乏 EFT 的特定因素。
- 常見學生誤解：以為關係好就是好督導，或以為技術教得多就是好督導。
- 教學重點：關係是核心，情緒焦點的技術讓它成為 EFT 督導。

洞見三：同理關係需要經驗與時間，不只是技巧

- 核心命題：專注、摘要等技能可以透過教學習得；創造並維持同理關係的能力，需要聽見更細微的感受與複雜的意義，較多透過經驗性學習，需要更多時間與個人發展。
- 臨床重要性：這解釋了為什麼 EFT 訓練強調經驗性學習與個人治療，也提醒學生不要因為一時學不會而自責。
- 對臨床推理的影響：規劃學習時，除了讀書與練習技巧，也要安排經驗性學習（例如親身經驗情緒工作）與個人成長。
- 例子：學生能在考試中寫出所有同理回應的類型，卻在晤談中聽不出個案語氣中的哀傷。這需要的不是更多講義，而是更多被指出與經驗的時間。
- 常見學生誤解：以為同理是可以一次學會的技巧清單。
- 教學重點：給同理時間；它是經驗與個人發展的成果。

洞見四：受督者怎麼學會，仍是最大的未知

- 核心命題：在「標記—任務環境—歷程—解決」的序列中，受督者的學習歷程是最少被研究、最不清楚的部分。作者呼籲以逐刻歷程研究督導，並走向能力本位、實證本位與可問責。
- 臨床重要性：這表示督導者無法只依賴模式，而需要持續觀察受督者是否真的在學習；受督者也可以主動觀察並回饋自己的學習。
- 對臨床推理的影響：每次督導後問：「我這次學到了什麼？是哪個督導行動幫助了我？」這本身就是對學習歷程的資料蒐集。
- 例子：受督者記錄每次督導中最有幫助的時刻，累積一學期後，發現「暫停錄影並試說一句」比「聽督導者講解」更有幫助。
- 常見學生誤解：以為督導模式已經把學習機制說清楚了。
- 教學重點：把自己的學習當作可以觀察、可以研究的歷程。

洞見五：從受督者所在之處開始

- 核心命題：作者提出階段式督導模式的構想：從簡單的同理訓練開始，再逐步推進到複雜的情緒焦點介入；並依受督者的同理天分、情緒能力與訓練階段調整。
- 臨床重要性：這與 EFT 治療中「先抵達，才能離開」的原則平行：督導也要在受督者目前所在之處與他相遇。
- 對臨床推理的影響：受督者可以評估自己目前在哪個階段，並與督導者協商相應的學習目標。
- 例子：碩一學生先把同理理解與探索性回應練熟，再學雙椅與空椅；而不是一開始就被要求做複雜的任務。
- 常見學生誤解：以為看過示範就應該能做到。
- 教學重點：學習本身，也需要先抵達，才能離開。

§4 關鍵原文引述

引述一

原文：

“Video and digital recording of treatment sessions now are like the microscope of psychotherapy and are of enormous value in psychotherapy supervision.”

中文意譯：「治療晤談的影像與數位錄影，現在就像心理治療的顯微鏡，對心理治療督導具有極大價值。」

出處：Greenberg & Tomescu (2017), Chapter 7, Future Directions, p. 148.

臨床意義：這個比喻說明為什麼 EFT 督導以錄影為核心：它讓細微的歷程，例如聲音品質的轉變、一聲嘆息、一個錯過的標記，變得可以被看見、被暫停、被討論。

教學意義：學生應理解錄影的價值，也要能批判地評估相關主張的證據（例如「錄影優於其他方法」未附引用），並在使用時遵守知情同意與保密規範。

引述二

原文：

“Of particular importance will be to study and specify the supervisee’s learning process, which, at the moment, remains the most uninvestigated and unclear aspect of our marker, task environment, process, and resolution sequence.”

中文意譯：「特別重要的，是研究並界定受督者的學習歷程；它目前仍是我們『標記—任務環境—歷程—解決』序列中，最少被研究、最不清楚的部分。」

出處：Greenberg & Tomescu (2017), Chapter 7, Future Directions, p. 148.

臨床意義：作者坦承模式中最關鍵的環節，也就是改變實際上如何發生，仍然未知。這是對模式限制的誠實說明。

教學意義：這句話邀請學生成為研究者：自己的學習經驗就是可以觀察的資料。它也提醒學生，任何督導模式都不應被當作已經完成的真理。

引述三

原文：

“...facilitating clients’ emotional deepening and engaging in specific marker-guided interventions are evidence-based processes that supervisors can feel confident should be taught in EFT supervision.”

中文意譯：「……促進個案的情緒深化，並投入特定的標記引導介入，是實證本位的歷程，督導者可以有信心地在 EFT 督導中教授。」

出處：Greenberg & Tomescu (2017), Chapter 6, Conclusion, p. 145.

臨床意義：這句話明確指出，本書最有證據支持的，是要教的內容：情緒深化與標記引導的介入。

教學意義：對照引述二，學生可以看見證據的分布：「教什麼」有較好的支持，「怎麼教、受督者怎麼學」仍待研究。這正是批判評估的核心練習。

§5 臨床推理框架

5.1 評估一個督導或治療主張的八個步驟

步驟	問題	本單元的具體做法
① 主張是什麼？	把主張寫成一句可檢驗的陳述	例：「錄影回饋比講授更能促進技能學習」
② 屬於哪一類證據？	對照證據地圖	直接研究／一般督導研究／理論模式／訓練研究／治療研究／作者主張
③ 原書提供了哪些研究細節？	樣本、設計、測量、效果	多數只摘述結論；如實標示「原書未說明」
④ 類推的前提是什麼？	對象、情境、文化	伴侶 EFT → 個人 EFT？北美 → 台灣？治療 → 督導？
⑤ 是相關還是因果？		例如情緒活化與結果的關聯屬於相關
⑥ 有哪些替代解釋？		期待效應、自我選擇、共同因素
⑦ 需要什麼研究才能檢驗？	設計一個研究	隨機分派、以晤談表現為結果、逐刻歷程分析

步驟	問題	本單元的具體做法
⑧ 在實務中如何使用？	依證據強度決定信心	有理由地採用，但持續評估，並保持修正的空間

5.2 設計自己的一學期學習計畫：四種訓練方法

方法	具體做法（從臨床實務角度的示例）	對應本書單元
概念學習	精讀推薦書目中的一本（例如 Elliott 等, 2004）；整理七種標記與任務	單元1、3
行為技能訓練	每週以同學的角色扮演練習一種同理回應；督導中練習「試說一句」	單元3、4
經驗性學習	參加經驗性工作坊；在安全的訓練團體中親身經驗雙椅或澄心聚焦	單元1、5
個人治療	考慮個人治療，處理自己面對某些情緒時的阻礙（自願，不列入評量）	單元1、5
錄影回饋	每兩週帶一段錄影與一個具體標記進督導	單元2、6

5.3 階段式學習的自我評估

階段（依原書構想整理）	核心技能	我目前的程度（1–5）
1. 同理基礎	在場、同理理解、探索性回應、同理臆測	
2. 知覺	聲音品質、經驗程度、喚起、生產性；辨識標記	
3. 概念化	追隨痛苦、核心自我組織、兩階段步驟	
4. 任務	雙椅、空椅、澄心聚焦等的步驟與微技巧	
5. 整合與個人化	彈性、多標記判斷、個人風格	

5.4 提出一個研究問題：受督者的學習歷程

項目	示例（從臨床實務角度）
研究問題	在 EFT 督導中，哪些督導者行動（示範、暫停錄影指出、請受督者試說）最常出現在受督者後續晤談技能改變之前？
設計	以任務分析取向，錄下督導與後續晤談；逐刻編碼督導者行動與受督者的回應；比較有解決與未解決的督導事件
測量	受督者晤談中的同理回應品質（例如依本書描述的同理類型編碼）；個案的經驗程度與情緒生產性
限制	小樣本；觀察者效應；因果推論困難；文化與機構差異

項目	示例（從臨床實務角度）
倫理	督導與晤談雙方的知情同意；資料保密；研究參與不影響評量